

CAPÍTULO 6.11

Indicaciones de Insulina

PERFIL EUNACOM 1.04.1.009
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Indicaciones de Insulina en Diabetes

Cuándo usar insulina (siempre)

TABLA 6.11.1: INDICACIÓN VS INSULINA / ESQUEMA	
INDICACIÓN	INSULINA / ESQUEMA
DM tipo 1 / LADA	Esquema intensificado: glargina 1×/día + cristalina 3×/día precomidas
CAD o HHO	Cristalina EV: bolo (10U o 0,1 U/kg) + goteo continuo
Embarazo	NPH (1-2 dosis) ± cristalina precomida
DM2 con HGO contraindicados (IRC ClCr < 30, IC severa)	NPH
DM2 con HbA1c > 9%	NPH nocturna 10U (inicio)
DM2 con 2 HGO máximos sin control	NPH nocturna
Diabético hospitalizado por causa grave	Cristalina c/6h por hemoglucómetro
Glicemia > 400 con síntomas	Hospitalizar + insulina

Cuándo considerar insulina (indicación relativa)

- Diabetes por corticoides (ej: lupus en prednisona)
- DM con síntomas intensos (poliuria, polidipsia, baja de peso) → iniciar insulina y evaluar cambio a HGO después si es DM2
- Neuropatía dolorosa o amiotrófica → puede mejorar dolor o ganancia muscular

Esquema en DM2 con insulina

- Inicio: NPH 10U nocturna SC

- Ajuste: aumentar NPH si pre-desayuno sigue alto
- Si prealmuerzo/presena altos: agregar NPH matinal
- Si postprandiales altas con precomidas normales: agregar cristalina precomidas

Al iniciar insulina en DM2

- Mantener metformina (ayuda control peso y glicemia)
- Otros HGO: suspender (a criterio según recursos y polifarmacia)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Hombre de 54 años con DM2 consulta por baja de 10 kg en 1 mes, polidipsia intensa y glicemia de 360 mg/dL con HbA1c 11.2%."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Indicación de Insulinoterapia Inmediata en DM2: presencia de síntomas cardinales severos con pérdida de peso rápida, HbA1c > 10% o glicemia > 300 mg/dL. La insulinización intensiva revierte la glucotoxicidad sobre las células beta.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- DM1 siempre requiere insulina desde el diagnóstico con esquema basal-bolo
- En DM2 se indica insulina al fracasar terapia oral máxima
- Indicaciones absolutas: CAD, EHHNC, embarazo, cirugía, enfermedad crítica
- Insulina basal en DM2 se inicia con 10 U o 0.1-0.2 U/kg nocturna
- Glargina y detemir son basales sin pico, NPH tiene pico a las 6-8 horas
- Se titula cada 3 días según glicemia de ayunas
- La hipoglicemia es el efecto adverso más importante de la insulina

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INDICACIONES DE INSULINA)

PREGUNTA 1

Paciente de 55 años con DM2 de 12 años de evolución, en tratamiento con metformina 2 g/día y glimepirida 4 mg/día. HbA1c actual 9.2%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ A) Agregar sitagliptina
- ☐ B) Iniciar insulina basal nocturna
- ☐ C) Aumentar glimepirida a 8 mg
- ☐ D) Cambiar a metformina de liberación prolongada
- ☐ E) Suspender todo e iniciar esquema basal-bolo

PREGUNTA 2

¿Cuál de las siguientes insulinas NO tiene pico de acción y proporciona un nivel basal más estable?

- ☐ A) NPH
- ☐ B) Insulina cristalina
- ☐ C) Insulina lispro
- ☐ D) Insulina glargina
- ☐ E) Insulina aspart

PREGUNTA 3

Paciente con DM2 inicia insulina NPH 10 U nocturna. Después de una semana, sus glicemias de ayunas están en 145-150 mg/dL. ¿Cuál es la conducta?

- ☐ A) Agregar insulina prandial al almuerzo
- ☐ B) Cambiar a glargina
- ☐ C) Aumentar NPH en 2 U cada 3 días hasta lograr meta
- ☐ D) Mantener dosis y esperar 4 semanas
- ☐ E) Duplicar la dosis a 20 U

RESUMEN: INDICACIONES DE INSULINA

La insulina es el tratamiento de elección en la diabetes tipo 1 y tiene indicaciones precisas en la diabetes tipo 2. En DM1 es indispensable desde el diagnóstico, utilizando esquemas basal-bolo que simulan la secreción fisiológica. En DM2, la insulina se indica cuando fracasa la terapia oral máxima, en descompensaciones agudas como cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, y en situaciones especiales como embarazo, cirugía, enfermedad crítica o insuficiencia renal y hepática avanzadas. Los tipos de insulina se clasifican por su perfil de acción. Las de acción ultrarrápida incluyen lispro, aspart y glulisina, con inicio en 15 minutos y duración de 3 a 5 horas. La insulina cristalina o regular tiene inicio en 30 minutos y dura 6 a 8 horas. Las intermedias como NPH inician en 1 a 2 horas y duran 12 a 18 horas. Las de acción prolongada como glargina y detemir duran 20 a 24 horas, y la degludec más de 42 horas. El esquema basal-bolo es el estándar en DM1: una insulina basal (glargina, detemir o NPH) más bolos prandiales de insulina ultrarrápida. En DM2, se suele iniciar con insulina basal nocturna (10 unidades o 0.1-0.2 U/kg) y titular cada 3 días según glicemia de ayunas. Si no se logran metas, se agregan bolos prandiales progresivamente.